Co-funded by
European Union
Humanitarian Aid

World Health
Organization

انجمن علمی روانپزشکان ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

بحران و تروما

انجمن علمی روانپزشکان ایران

با همکاری دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، و سازمان جهانی بهداشت

فرهنگ بحران چیست؟

- مجموعه ارزش‌ها، هنجارها، باورها و روایت‌ها
- تجربه فردی و جمعی از فجایع
- سازماندهی رفتارهای اجتماعی و پاسخ‌های رسمی
- میزان آمادگی ذهنی و عملی

1. اطلاعات و مهارت لازم برای مواجهه با بحران
2. آمادگی پذیرش روانی واقعیت‌های تهدیدآمیز
3. کفایت منابع و امکانات برای واکنش سریع

چرا باید فرهنگ بحران را بشناسیم؟

- تشخیص اینکه چه چیزی بحران هست و چه چیزی نیست
- امکان فهم و پیشبینی بهتر تجربه بحران
- امکان واکنش مناسب
- ایجاد حس امنیت و افزایش مشارکت

تعاریف مربوط به تروما

تروما

- تجربه‌ای جسمی/ روانی است که ظرفیت فرد برای تنظیم هیجان، احساس امنیت و معنا دادن به تجربه را مختل می‌کند.
- همراه با حس در خطر بودن، کنترل نداشتن و آینده غیرقابل پیشبینی
- اهمیت تجربه درونی و **نه شدت رویداد**

ترومای جمعی

- وضعیتی که در آن یک جامعه یا گروه بزرگ انسانی با رویدادهایی مواجه می‌شود که به‌صورت گسترده احساس امنیت، عدالت و پیش‌بینی‌پذیری را مختل می‌کند.
- آسیب فراتر از فرد
- اختلال در روابط، اعتماد و معنای مشترک

اثر بر درمانگران:

- مشاهده مستقیم خشونت یا پیامدهای آن
- مواجهه مستمر با آسیب و سوگ
- تجربه ناامنی، بی‌اعتمادی یا فشار ساختاری
- کاهش تمرکز، تحریک‌پذیری، خستگی یا بی‌حسی هیجانی

ترومای مشترک

- ترومای همزمان به مراجع و درمانگر
- اثر بر فرایند درمان، مرزهای حرفه‌ای و تنظیم هیجانی

- فرصت: افزایش ظرفیت همدلی و درک عمیق‌تر از تجربه زیسته مراجعان
- تهدید: خطر فرسودگی، درهم‌تنیدگی هیجانی و تضعیف مرزهای حرفه‌ای
- راهکار: خودآگاهی مستمر درمانگر، توجه به وضعیت هیجانی شخصی و مراقبت از مرزهای حرفه‌ای

آسیب اخلاقی

- زمانی که فرد احساس کند نتوانسته مطابق ارزش‌های حرفه‌ای یا انسانی خود عمل کند، یا شاهد اقداماتی بوده که با اصول بنیادین او در تعارض است.
- هسته اصلی شرم, و احساس گناه است نه ترس
- لزوم وجود فضایی امن و غیرقضاوتی برای پرداختن به تعارض‌ها

نشانه‌های رایج آسیب اخلاقی:

- احساس شرم یا گناه پایدار
- خشم نسبت به ساختارها یا تصمیم‌گیرندگان
- حس درماندگی و بی‌اختیاری
- تردید در هویت یا فرسایش معنای فعالیت حرفه‌ای

مراقبت و مداخلات آگاه به تروما

مراقبت آگاه به تروما چیست؟

- پیشفرض احتمال سابقه تروما در مراجعین
- با هدف کاهش احتمال بازتجربه احساس ناایمنی، تحقیر یا بی‌اختیاری در محیط بالینی
- توجه به سه اصل [illegible]
- مقدمه ضروری تمام مداخلات، و نه یک درمان تخصصی
- بخشی از مسئولیت حرفه‌ای و نه یک مداخله تجملی
- هدف درمان ایجاد ایمنی نسبی و پیشگیری از آسیب بیشتر است و نه مواجهه با گذشته و پردازش عمیق تروما

تمرکز مراقبت:

- شناخت تأثیر تروما بر سیستم عصبی
- عادی‌سازی واکنش‌های طبیعی به شرایط غیرعادی
- تنظیم تدریجی برانگیختگی
- محدود نگه‌داشتن دامنه مداخله
- پرهیز از بازفعال‌سازی ناخواسته

رویکردها و مداخلات کاربردی در تروما

محورهای کلیدی مداخله در تروما

- **آمادگی درمانگر**

خودآگاهی، تحمل هیجان شدید، تشخیص محدودیت و ارجاع در صورت فرسودگی

- **هدف مداخله در بحران**

ایجاد امنیت نسبی، کاهش برانگیختگی، حفظ کارکرد حداقلی و تثبیت شرایط و نه پردازش و مواجهه با تروما

- **حفظ روزمرگی**

برنامه ساده و منظم روزانه، فعالیت دستی سبک، حس کنترل و تداوم

- **تنظیم اضطراب و نگرانی**

حرکت بدن، تمرکز حسی، ارتباط انسانی و اطلاع از ماهیت گذرای حملات عصبی.

- **مواجهه با بی‌حسی و آپاتی**

فعال‌سازی تدریجی، نوشتن، تماس اجتماعی محدود، تمرکز حسی برای خروج از خاموشی.

اصول درمان شناختی-رفتاری در بحران

- **واقعیت‌محوری به‌جای اطمینان‌بخشی**

تفکیک واقعیت از شایعه و فاجعه‌سازی؛ پرهیز از آرام‌سازی سطحی؛ تمرکز بر آنچه واقعاً می‌دانیم

- **بهداشت شناختی**

محدودسازی و زمان‌بندی دریافت اخبار؛ استفاده از منابع معتبر؛ کاهش بار شناختی و برانگیختگی مزمن

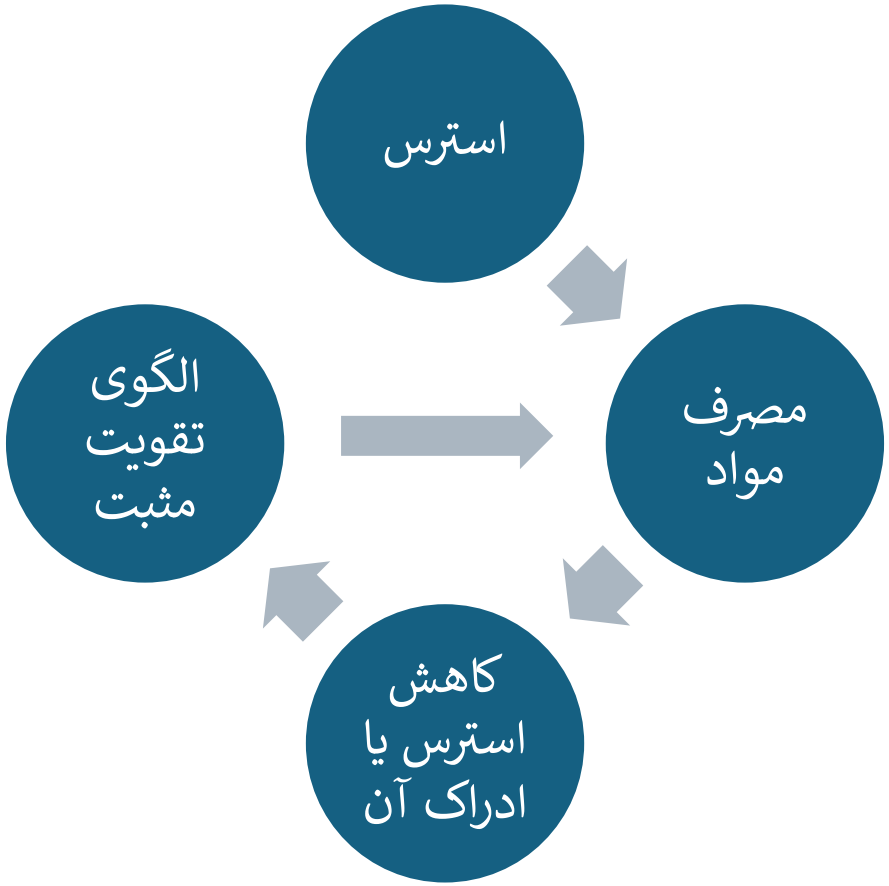
- **شناسایی خطاهای شناختی**

خطاهایی چون تعمیم افراطی، هم‌آمیزی زمانی، بزرگ‌نمایی، استدلال هیجانی، نادیده‌گرفتن جنبه‌های مثبت

- **هدف درمانی در بحران**

ایجاد فاصله شناختی ملایم و تقویت واقعیت‌سنجی تدریجی (نه اصلاح کامل باورها)

سوءمصرف مواد و الکل پس از تروماهای جمعی



چرا میل به مصرف افزایش می‌یابد؟

- **تجربه‌های جسمی:** برانگیختگی مفرط، گوش‌به‌زنگی و بی‌خوابی.
- **تجربه‌های روانی:** اضطراب منتشر، افکار مزاحم (فلش‌بک) و نوسانات خلقی.
- **احساسات بنیادین:** ناتوانی، فقدان کنترل و بی‌حسی هیجانی.

وضعیت مصرف مواد در کادر درمان پس از تروماهای گسترده

شیوع

- ۱۵ تا ۲۵٪ کارکنان: افزایش مصرف **الکل** یا **آرام‌بخش‌ها** در ماه‌های نخست پس از بحران
- معمولاً با کاهش فشار فروکش می‌کند، اما در ۵ تا ۱۵٪ موارد **پایدار** می‌شود

پیش‌برنده‌های افزایش مصرف

شدت بالای PTSD
بی‌خوابی مزمن
فرسودگی شغلی

عوامل تشدیدکننده

شیفت‌های طولانی و خستگی مزمن
دسترسی آسان به دارو
فرهنگ حرفه‌ای: **انکار آسیب‌پذیری**
نگرانی از **انگ** و پیامد شغلی
تاب‌آوری اجباری

رویکرد یکپارچه به مصرف مواد

درک رنج زیربنایی	کاهش انگ	شناسایی زودهنگام	مداخله پیشگیرانه
اضطراب حاد بی‌خوابی افکار مزاحم بی‌حسی هیجانی	ایجاد فضای امن تأکید بر محرمانگی کاهش رویکرد تنبیهی	مداخله زودهنگام، حمایتی و ساختاریافته	آموزش بهداشت خواب پرهیز از تجویز طولانی‌مدت بنزودیازپین‌ها درمان دارویی و غیردارویی مناسب جلوگیری از تثبیت الگوی مصرف

به طور خلاصه

- لزوم شناسایی فرهنگ بحران
- هدف تثبیت شرایط است و نه پردازش تروما
- توجه به اصول [illegible]
- لزوم توجه به آسیب‌پذیری کادر درمان در تروما

در بحران، مداخله مؤثر یعنی دیدن رنج، حفظ کرامت، کاهش آسیب و ساختن امکان ادامه‌دادن